EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90366
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-09 16:16:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SIBILA LEIVA VENEGAS			RUN	: 8.354.141-5
F.Nac	: 12-10-2022	Edad	: 1 AÑO, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-06	Fecha Egreso	: 2024-08-09 16:16:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INFECCION DEL TRACTO URINARIO ALTO-->PIELONEFRITIS AGUDA DERECHA
FALLA RENAL AGUDA AKI KDIGO 3
ESTENOSIS SIGNIFICATIVA DEL ORIGEN DE LA ARTERIA MESESENTERICA SUPERIOR Y AMBAS ARTERIAS RENALES
HTA SISTEMICA
ARTRITIS REUMATOIDE
LCFA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

¬¬¬PCTE CON ANTEC: HTA SISTEMICA, ARTRITIS REUMATOIDE, LCFA CON TRATAMIENTO REGULAR QUIEN REFIERE INICIO DE CUADRO CLINICO 2 DIAS PREVIO A CONSULTA EN URGENCIAS EL 05/08. CARACTERIZADO POR FIEBRE NO CUANTIFICADA, MIALGIAS , DOLOR ABDOMINAL EN HIPOGASTRIO ASOCIADO A COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL POR LO QUE ACUDE AL SU HSC DONDE INGRESA EN REGULARES CONDICIONES GENERALES , DESHIDRATADA, FEBRIL .
SOLICITAN LABORATORIOS DESTACANDO PARAMETROS INFLAMATORIOS ELEVADOS (PCR 225MG) CREA: 2.0 MG/DL, LEUCOCITOSIS CON NEUTROFILIA Y SEDIMENTO ORINA PATOLOGICO. REALIZAN SCANNER ABDOMEN QUE REPORTA: ESTENOSIS HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVA EN EL ORIGEN DE LA ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR Y AMBAS ARTERIAS RENALES POR PLACAS DE ATEROMA BLANDO. AUMENTO DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO ADIPOSO PERIRRENAL BILATERAL DE PREDOMINIO DERECHO, CON REALCE DE ASPECTO INFLAMATORIO DEL UROTELIO DE PELVIS RENAL DERECHA. INGRESA A MEDICINA PARA CONTINUAR MANEJO. INICIANDO TTO ATB CON CEFTRIAXONA
PCTE EN SALA EN BCG, SE SIENTE MEJOR, AFEBRIL, SE ALIMENTA OK, HD ESTABLE, ASINTOMATICA
EVALUADA POR CIRUGIA 08/08 (POR ESTENOSIS ARTERIA MESESENTERICA SUPERIOR Y AMBAS A. RENALES): SOLO OBSERVACION A FUTURO DE SIGNOLOGIA ABDOMINAL, ALTA DE CIRUGIA (DR. ZUGBE)
CON BUENA RESPUESTA CLINICA Y DE LABORATORIO (PARAMETROS DE CONTROL HOY A LA BAJA)
POR ESTA RAZON SE DECIDE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA COMPLETAR TTO ATB EV

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR 7 DIAS TTO ATB EV

INDICACIONES AL ALTA

1. SE DERIVA A HODOM
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO
4. CEFTRIAXONA 2 GR EV AL DIA PARA COMPLETAR 7 DIAS
5. PARACETAMOL 500MG 2 C/8HRS VO SOS SI DOLOR O FIEBRE
6. OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
7. RESTO TTOS CRONICOS MANTENER

EXÁMENES Y RESULTADOS

06/08:
TC ABD-P: ESTENOSIS HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVA EN EL ORIGEN DE LA ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR Y AMBAS ARTERIAS RENALES POR PLACAS DE ATEROMA BLANDO. AUMENTO DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO ADIPOSO PERIRRENAL BILATERAL DE PREDOMINIO DERECHO, CON REALCE DE ASPECTO INFLAMATORIO DEL UROTELIO DE PELVIS RENAL DERECHA.

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO